

INDICADO POR: *Opelle*☒ ACOMPANHAMENTO ☐ CONSULTA

NS 22231696973 / 900

ANDRE ATILIO TISSI

IDADE: 65 PESO: 93 ALTURA: 175 PROFISSÃO: *administrador*
SINTOMAS: *ansiedade / dor de cabeça / cansaço / sonolência*
(após almoço)
QUEIXAS: *dor facial / esposa relata ronco / Bruxismo.*
MEDICAMENTOS: *Dulocetiver / Noratriptol / apazolam.*

MÉDICO: *Dr. Mario Sérgio / Dr. Douglas.*MARCAPASSO: ☐ S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: ☐ S ☒ NEXERCÍCIO FÍSICO: *musculação todos os dias (1:30)*

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: S

HORA QUE DORME: 21:30 HORA QUE ACORDA: 5:30

COCHILHO ☒ S ☐ N 1h DORME ACOMPANHADO: ☐ S ☒ N ☐ EVENTUALMENTE *esposa*TEM FILHOS: ☐ S ☒ N / DORMEM NO QUARTO: ☐ S ☒ N PET NO QUARTO: ☐ S ☒ NBEBIDA ALCOÓLICA: ☒ S ☐ X NA SEMANA ☐ N *eventual*FUMO: ☐ S ☐ MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:TIPO DE RESPIRAÇÃO: *nasal* BANHEIRO/NOITE: 2 a 3XCIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: *normal* CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO: —OVERLAP: *não* MALLAMPATI: III IAH: 58,1h SPO2:PATOLOGIAS ASSOCIADAS: *Desvio septo / Alergia a açúcar / gastrite*CIRURGIAS: ☒ NASAL ☐ AMIGDALECTOMIA 3x desvio septo.HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: *negativa*COMORBIDADE: ☐ RESPIRATÓRIA ☐ ENDÓCRINA ☐ CARDÍACA☐ ORTOPÉDICA ☐ NEUROLÓGICA ☐ OUTROS:POLISSONOGRAMA COM CPAP: ☐ S ☐ N SPO2 C/ CPAP: PRESSÃO NO EXAME:11/12 Avaliação
24Mar. *Wisp* *tecido* (XL)18/12/24 P: 8,8 cmH₂O P95: 10,9 cmH₂O → Auto 5 a 13 cmH₂O

IAH: 8,0 e/h

m uso: 7h 40 min.

fuga: 14 l/min

P: 6 a 11 cmH₂OP rampa 5 cmH₂O.

Séria

26/12/24 P: 9,4 cmH₂O

IAH: 5,0 e/h (Ac)

m uso: 7h 50 min

fuga: 14 l/min.

P rampa fixa: 9,4 cmH₂OP rampa: 5,4 cmH₂O.

Séria

07/01/25 P: 9,4 cmH₂O

IAH: 5,4 e/h

m uso: 7h 30

fuga: 21 l/min

P: 9,0 cmH₂OP: 6,0 cmH₂O rampa

Séria

15/01/25 P: 9,0 cmH₂O

IAH = 6 elh

muco = 8h40min

fuga = 20l/min

P: 9,4 cmH₂O.

29/01 2025 P: 9,4 cmH₂O

IAH = 4,1 elh

muco = 8h46min

fuga = 30l/min

↑ dose de nifedipina

↑ fazendo mais atividade física

Silvia

19/02 25 P: 9,4 cmH₂O

IAH = 3,1 elh

M. de uso: 8h30'

fuga = 26,4 l/min

exerc. físico 5x semana
lavagem nas. todos os dias

Sra. Cláudia

26/03 2025

P: 9,4 cmH₂O

IAH = 2,9 elh

muco = 8h48min

fuga = 37l/min

Silvia

26/05 2025 P: 9,4 cmH₂O

IAH = 2,9 elh

muco = 7h14min

fuga = 34l/min

Bem Adaptado.

* novo filtro *

Silvia



Clínica

DR. ALBERTO REMESAR

Psiquiatria do bem-estar

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

Psiquiatria pela UFRJ

Mestre em Psiquiatria pela UFRJ

Doutor em Ciências pela UNIFESP

Medicina do Sono pela Soc. Brasileira do Sono

CRM 69.730 - RQE 40.178

LAUDO DA POLISSONOGRAMA

NOME: André Atilio Tissi

EXAME nº: 5674

SOLICITADO POR: Dr. Mário Sérgio Leone Carregosa

DATA: 27/11/2024

IDADE: 65 anos

Comentários:

Exame iniciado às 21h47min e concluído às 05h14min. A latência para o sono foi de 13 minutos e a latência para o estágio REM, de 152 minutos. O tempo total de sono foi de 344,5 minutos (05h44min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 79,6%. A distribuição do sono mostrou 21,3% de estágio 1, 52,2% de estágio 2, 0% de estágio 3 e 26,4% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 75 minutos em vigília, ocorreram 123 microdespertares (índice: 21,4/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 58/hora, sendo 16,4 apneia/hora e 41,6 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 58,7/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 90%, sendo a média de 91% e a mínima de 78%.

(*) TTS ⇨ Tempo Total de Sono

TTR ⇨ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (58/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (58,7/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, despertares e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 62; máxima: 80 bpm.

O ronco foi intermitente e baixo.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 13 min; normal até 30 min). A latência para o sono REM estava alongada (152 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 79,6%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (índice: 21,4/hora; normal até 15/hora). Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (21,3%; normal: 8-10%) e REM (26,4%; normal: 20%). A porcentagem do estágio 2 (52,2%; normal: 45-55%) permaneceu nos limites da normalidade. Ausência do estágio 3 (0%; normal: 10-12%).

Sem movimentos periódicos de membros.

Observei esporádicas contrações masseterinas após despertares.

Escala de Sonolência de Epworth: 7 (normal até 9; máxima: 24).

Avenida Dr. João Guilhermino, 474 - salas 51 e 52
Edifício Office Tower - Centro - São José dos Campos
Tel: (12) 3913-2162 / (12) 3941-2449 / (12) 99622-8008

Alberto Jorge Remesar Lopez
Médico
CRM 69730 - RQE 40178